PEDIATRIC SURGERY · ESSAY PREDICTIONS

Pediatric Surgical Nursing Essay Questions — Predictions

جراحة الأطفال — توقعات الأسئلة المقالي

8	4	3	1
Predicted essays	Very high	High	Medium

طريقة التوقع: ملف «Pediatric Surgery Final» من الجروب فيه جزء مقالي من امتحان الفاينال (Laparoscopy، Intestinal obstruction، Blood transfusion، Hypothermia) — دي أقوى توقعات لأنها جت فعلاً. ضفت عليها أسئلة متوقعة من محاضرات القائمة (CHPS/TOF، الفتق والخصية، الانغلاف وتشوهات الشرج) حسب تكرارها في الـ MCQ. مفيش توقع مضمون 100%.

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلَّا ما جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وأنتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سَهْلًا — صلِّ على النبي ﷺ

Predicted Essay Questions

الأسئلة المتوقعة مرتبة حسب قوة التوقع

E1 **Mention the advantages and disadvantages of laparoscopic surgery in children.** — توقع عالي جدا

المحاضرة: الرعاية الجراحية للأطفال (Pediatric Surgical Care) — جه في الفاينال كسؤال مقالي.

المصدر: فاينال جراحة أطفال (ملف من الجروب)

E2 **Enumerate the causes, clinical manifestations and management of hypothermia in children.** — توقع عالي جدا

المحاضرة: الرعاية الجراحية للأطفال (Pediatric Surgical Care) — جه في الفاينال (3 أجزاء).

المصدر: فاينال جراحة أطفال (ملف من الجروب)

E3 **List the complications of blood transfusion.** — توقع عالي جدا

المحاضرة: الرعاية الجراحية للأطفال (Pediatric Surgical Care) — جه في الفاينال.

المصدر: فاينال جراحة أطفال (ملف من الجروب)

E4 **Enumerate the causes of intestinal obstruction in the neonate and the nursing care.** — توقع عالي جدا

المحاضرة: تشوهات الشرج والمستقيم (Anorectal Malformations) — جه في الفاينال + متكرر في الميدترم (NGT، IV line).

المصدر: فاينال جراحة أطفال (ملف من الجروب)

E5 **Discuss the pre- and post-operative nursing care of an infant with esophageal atresia/TOF.** — توقع عالي

المحاضرة: ضيق البواب الخلقي والناسور المريئي الرغامي (CHPS & Tracheo-Oesophageal Fistula) — متكرر جداً في الـ MCQ (excess saliva، failure to pass Ryle، gastrostomy).

المصدر: توقع

E6 **Describe the clinical picture and nursing management of congenital hypertrophic pyloric stenosis.**

توقع عالي

المحاضرة: ضيق البواب الخلقي والناسور المريئي الرغامي (CHPS & Tracheo-Oesophageal Fistula) — متكرر في ميدترم 2025 وميدترم السنة اللي فاتت.

المصدر: توقع

E7 **Discuss intussusception: clinical manifestations and management.**

توقع عالي

المحاضرة: الانغلاف المعوي (Intussusception) — متكرر (pneumatic reduction، air enema).

المصدر: توقع

E8 **Compare inguinal hernia, hydrocele and undescended testis regarding clinical picture and timing of surgery.**

توقع متوسط

المحاضرة: الحالات الجراحية الشائعة (الفتق والقيلة المائية والخصية المعلقة) Common Pediatric Surgical Conditions (Hernia, Hydrocele & UDT) — متكرر في ميدترم 2025.

المصدر: توقع

Model Answers

نقاط الإجابة النموذجية

E1. Mention the advantages and disadvantages of laparoscopic surgery in children.

- Advantages: minimally invasive
- Faster recovery
- Better cosmetic outcome
- Reduced blood loss
- Improved visualization
- Disadvantages: requires specialized training
- Injury to internal organs/vessels/bowel
- Increased cost
- Conversion to open surgery
- Limited access in emergencies
- Complications: anaphylaxis, hypoxia, hypothermia, nausea & vomiting, infection, incisional hernia, adhesions, pulmonary embolism

E2. Enumerate the causes, clinical manifestations and management of hypothermia in children.

- Causes: environmental (cold, water immersion, inadequate heating)
- Neonatal: prematurity, LBW
- Medical: sepsis, hypoglycemia, hypothyroidism, CNS lesions
- Trauma/surgery: blood loss, exposure
- Neglect, malnutrition, dehydration, drugs
- Mild: shivering, tachycardia, tachypnea, pale skin
- Moderate: slow breathing & HR, slow movements, cyanosis, weak pulse, low BP
- Severe: loss of shivering, hypotension, oliguria, stiffness, coma, cardiac arrest
- Management: regulate environment temperature
- Remove wet clothes; dry covering/blankets (passive warming)
- Warm fluids & warmed IV fluids
- Heated humidified oxygen
- Monitor temperature during rewarming

E3. List the complications of blood transfusion.

- Acute or delayed hemolytic transfusion reaction
- Circulatory overload
- Hyperkalemia → arrhythmia
- Pulmonary embolism (platelet overload)
- Thrombophlebitis
- Hemosiderosis (iron overload) with repeated transfusion

E4. Enumerate the causes of intestinal obstruction in the neonate and the nursing care.

- Duodenal & jejunal atresia/stenosis
- Anorectal malformations (imperforate anus)
- Hirschsprung disease
- Meconium ileus
- Malrotation with volvulus
- Adhesions, strangulated hernia, intussusception
- Tumors, paralytic ileus
- Care: NPO + NGT (prevent aspiration)
- IV line, fluids & electrolytes
- Monitor vomiting, distension, urine output
- Prepare for surgery; family support

E5. Discuss the pre- and post-operative nursing care of an infant with esophageal atresia/TOF.

- Pre-op: NPO
- Continuous suction of upper pouch
- Head elevated 30–40°
- IV fluids, warmth, antibiotics as ordered
- Prepare for thoracotomy/thoracoscopy
- Post-op: chest tube & gastrostomy care
- Suction carefully (marked catheter)
- Oral stimulation (pacifier)
- Monitor for anastomotic leak/stricture
- Teach parents gastrostomy/esophagostomy care

E6. Describe the clinical picture and nursing management of congenital hypertrophic pyloric stenosis.

- Age 3–6 weeks, males, first-born
- Projectile non-bilious vomiting, hungry baby
- Olive-shaped mass, visible peristalsis
- Dehydration, weight loss
- Hypochloremic hypokalemic metabolic alkalosis
- Pre-op: correct fluids/electrolytes, NGT, I&O, weight
- Pyloromyotomy (not emergency)
- Post-op: feeds after 4–6 h gradually, burp, wound care, family teaching

E7. Discuss intussusception: clinical manifestations and management.

- Telescoping of bowel, commonly ileocolic, 6 months–2 years
- Sudden colicky pain with drawing up of legs
- Vomiting, sausage-shaped mass
- Red currant-jelly stool
- Diagnosis: ultrasound (target sign)
- Air/hydrostatic enema — diagnostic & therapeutic
- Surgery if reduction fails or peritonitis
- Watch for normal brown stool after reduction

E8. Compare inguinal hernia, hydrocele and undescended testis regarding clinical picture and timing of surgery.

- Inguinal hernia: reducible groin swelling ↑ with crying; operate once diagnosed
- Incarceration/strangulation = emergency
- Hydrocele: soft painless transilluminating swelling; observe till ~2 years
- Undescended testis: commonest site inguinal canal; orchiopexy 6–12 months
- Complications of UDT: infertility, torsion, malignancy